

Kronik/Fonksiyonel Karın Ağrısı

Rome IV temelli pozitif tanı yaklaşımı: fonksiyonel karın ağrısı bozukluklarının (fonksiyonel dispepsi, IBS, abdominal migren, FAP-NOS) ayrımı, alarm bulgularının taranması, sınırlı non-invaziv tetkik, biyopsikososyal yönetim ve gereksiz tetkikten kaçınma. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Rome IV

FAP-NOS

Alarm bulguları

Biyopsikososyal

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kronik karın ağrısı, en az 2 ay süren sürekli veya tekrarlayan ağrıdır. Rome IV, çocukta fonksiyonel karın ağrısı bozukluklarını (FAPD) beyin-bağırsak etkileşiminin bozulduğu, pozitif klinik tanı konulabilen bir şemsiye altında tanımlar: fonksiyonel dispepsi, irritabl bağırsak sendromu (IBS), abdominal migren ve başka türlü sınıflanamayan fonksiyonel karın ağrısı (FAP-NOS). FAP-NOS tanısı için ≥ 2 ay boyunca ayda ≥ 4 kez: fizyolojik olaylara (yemek, adet) münhasır olmayan epizodik/sürekli karın ağrısı, IBS–fonksiyonel dispepsi–abdominal migren kriterlerinin karşılanmaması ve uygun değerlendirme sonrası ağrının başka bir tıbbi durumla tam açıklanamaması gerekir.

Fonksiyonel dispepsi — postprandiyal dolgunluk / epigastrik ağrı

IBS — dışkılama ile ilişkili ağrı + bağırsak alışkanlığı değişimi

Abdominal migren — paroksizmal, günlük işlevi bozacak kadar şiddetli, aralarda tam iyilik

FAP-NOS — diğer üç fenotipe uymayan fonksiyonel ağrı

Öyküde sorgula

- Ağrı paterni: lokalizasyon (periumbilikal tipik), süre, sıklık (ayda ≥ 4 kez, ≥ 2 ay), epizodik mi sürekli mi
- Fenotip ipuçları: yemekle ilişki/dispepsi, dışkılama ile ilişki/IBS, paroksizmal-aralarda tam iyilik/abdominal migren
- İşlevsel etki: okul devamsızlığı, uykudan uyanma, aktivite kısıtlanması, yaşam kalitesi
- Alarm sorgusu: kilo kaybı, gece semptomu, GIS kanama, safralı/inatçı kusma, ateş, disfaji
- Diyet-semptom ilişkisi: laktoz, fruktoz, FODMAP, kafein; beslenme günlüğü ve büyüme öyküsü
- Psikososyal: anksiyete, depresyon, somatizasyon, stresör, uyku; ebeveyn kaygısı ve pekiştireç davranışları
- Aile öyküsü: IBD, çölyak, peptik ülser, migren; ilaç kullanımı (NSAİİ)

Muayenede değerlendir

- Büyüme: boy-kilo persentilleri, boy hızı ve puberte evresi; doğrusal büyümede duraklama alarmıdır
- Karın: periumbilikal/değişken hassasiyet tipik; lokalize hassasiyet, kitle, organomegali, defans patolojiktir

- Carnett testi: pozitifse abdominal duvar kaynaklı ağrı düşün (viseral değil)
- Perianal/rektal: fissür, fistül, deri lezyonu, gizli kan (IBD lehine ipuçları)
- Ekstraintestinal: solukluk, aftöz lezyon, artrit, döküntü, çomak parmak, vertebral/KVA hassasiyeti
- Amaç: kapsamlı dışlama değil, alarm yokluğunda FAPD'nin pozitif klinik tanısını desteklemek

Alarm bulgusu yoksa ve büyüme normalse fonksiyonel karın ağrısı bir dışlama tanısı değil **pozitif klinik tanı** olarak konulmalıdır; geniş, invaziv tetkik rutin gerekmez. Fazla test, aile kaygısını ve semptom yükünü artırıp somatizasyonu pekiştirebilir.

FAPD tek nedenli değildir; üst üste binen biyolojik, psikolojik ve sosyal yolların oluşturduğu bozulmuş beyin-bağırsak etkileşimidir. Baskın mekanizmayı öngörmek, hedefe yönelik biyopsikososyal tedavi seçimini (diyet, nöromodülatör, davranışsal tedavi) yönlendirir.

Visseral hipersensitivite

- Luminal gerilme/distansiyon uyarana artmış algı eşliği düşüklüğü
- Ağrının santral amplifikasyonu ve alogezi
- Hedef: nöromodülatör, hipnoterapi, antispazmodik

Beyin-bağırsak eksenı disregölasyonu

- Santral duyarlılaşma, otonom ve HPA eksenı dengesizliğı
- Ağrının inen inhibitör kontrolünde yetersizlik
- Hedef: BDT, gut yönelimli hipnoterapi, TCA/SSRI

Motilite ve otonom bozukluk

- Gastrik akomodasyon/boşalma bozukluğu (dispepsi), transit değışkenliğı (IBS)
- Aşırı gastrokolik yanıt, postprandiyal semptom
- Hedef: prokinetik/asit baskılama, alt tipe göre motilite düzenleyici

Mikrobiyota / post-enfeksiyöz / mukozal immün

- Disbiyoz; akut gastroenterit sonrası post-enfeksiyöz başlangıç
- Düşük dereceli mukozal immün aktivasyon, mast hücre komşuluğı, geçirgenlik artışı
- Hedef: probiyotik denemesi, diyet düzenlemesi

Psikososyal ve öğrenilmiş faktörler

- Anksiyete, depresyon, somatizasyon; stresör ve olumsuz yaşam olayları
- Ebeveyn kaygısı, dikkat pekiştirmesi ve hastalık davranışının öğrenilmesi
- Hedef: aile eğitimi, davranışsal tedavi, okul dönüşü

Genetik / erken yaşam / diyet

- Ailesel yatkınlık; erken yaşam olayları ve ağır deneyimleri
- Diyet tetikleyicileri: FODMAP, laktoz/fruktoz malabsorpsiyonu, kafein
- Hedef: hedefli eliminasyon-reintroduksiyon, tetikleyici yönetimi

03 Karar akışı

Klinik değerlendirme sonrası ilk çatal alarm bulgusudur; ikinci çatal Rome IV uyumu ve sınırlı non-invaziv taramanın normalliğidir. Amaç, alarm yokluğunda pozitif tanıya hızla ulaşıp tetkik yükünü minimize etmektir.

BAŞLANGIÇ

≥2 aydır süren kronik/tekrarlayan karın ağrısı

Ayda ≥4 kez, fizyolojik olaylara münhasır olmayan epizodik veya sürekli ağrı; işlevselliği etkiliyor.

ADIM 1

Öykü + muayene + büyüme + fenotip sınıflaması

Diyet-semptom ilişkisi, psikososyal ve aile öyküsü; persentil/boy hızı/puberte; dispepsi–IBS–abdominal migren–FAP–NOS ayrımı.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı?

Kilo kaybı, büyüme duraklaması, GIS kanama, gece uyandıran ağrı/ishal, safralı-inatçı kusma, disfaji, perianal hastalık, ateş, IBD/çölyak aile öyküsü.

EVET → Organik hastalığı dışla

HAYIR → Sınırlı non-invaziv değerlendirme

HEDEFLİ TETKİK

Fenotipe yönelik lab + görüntüleme ± endoskopi

Klinik yönelimle üst/alt endoskopi + biyopsi, US/MR enterografi ve hedefli laboratuvar: IBD, çölyak, eozinofilik hastalık, enfeksiyon, cerrahi patoloji.

BASAMAKLI TARAMA

İlk-basamak sınırlı test

Tam kan, CRP/sedim, çölyak serolojisi, fekal kalprotektin ± Giardia/gaita; fenotipe göre hedefli ekle. Kapsamlı taramadan kaçın.

KARAR 2

Rome IV karşılandı ve tarama normal mi?

Semptomlar başka durumla açıklanamıyor; kalprotektin ve çölyak serolojisi negatif, büyüme normal.

EVET → Pozitif tanı

HAYIR → Yeniden değerlendir

TANI

İLERİ TETKİK

Endoskopi / hedefli inceleme

FAPD (dispepsi / IBS / abdominal migren / FAP-NOS)

Biyopsikososyal açıklama ve etkin güvence; fenotipe yönelik diyet, davranışsal tedavi ve gerekirse dozlu farmakoterapi; 4 haftalık izlem.

Kalprotektin yüksek, seroloji pozitif veya dirençli-atipik seyir: endoskopi + biyopsi ve mekanizmaya yönelik ek değerlendirme.

Alarm bulgusu yoksa tetkik kademeli ve sınırlı tutulur; ampirik geniş panel, ultrasonografi ve endoskopi rutin olarak endike değildir. Endoskopi/kolonoskopi alarm, kalprotektin yüksekliği veya tedaviye dirençli olgulara ayrılır.

Alarm bulgusuz kronik/fonksiyonel karın ağrısında kademeli değerlendirme

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Kan	Tam kan sayımı, CRP/ESR, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA), KCFT, üre/kreatinin	Anemi, inflamasyon ve çölyak taraması; hepsi normal belirgin düşer
Basamak 2 · Gaita	Fekal kalprotektin; gaita mikroskopisi/kültürü, Giardia antijeni, gizli kan	Kalprotektin <50 µg/g IBD dışlar; >250 µg/g end
Dispepsi · hedefli	H. pylori dışkı antijeni; alarm/dirençli olguda üst GİS endoskopi + biyopsi	Test-and-treat pediatri de önerilmez; H. pylori yalnız biyopsi ile doğrulanıp tedavi edilir
IBS/diyet · hedefli	Seçili olguda laktoz/fruktoz H ₂ nefes testi; beslenme günlüğü	Karbonhidrat malabsorpsiyonu-diyet ilişkisi; rutin de
Basamak 3 · Görüntüleme	Batın ultrasonografisi	Lokalize ağrı, organomegali, kitle veya safra/böbre tarama amacıyla değil
Basamak 4 · Endoskopi	Üst GİS endoskopi ve/veya ileokolonoskopi + biyopsi	Alarm bulgusu, kalprotektin yüksekliği veya tedaviye çölyak, eozinofilik özofajit/gastroenterit, peptik hast

Fekal kalprotektin ve çölyak serolojisi fonksiyonel ağrıyı organik hastalıktan ayırmada en yararlı non-invaziv testlerdir; ikisi de normal ve alarm yoksa rutin endoskopi/görüntülemekten kaçının. Kalıcı

kalprotektin yüksekliđi (>250 µg/g) veya klinik alarm tanıyı sorgulatıp endoskopiı gerektirir.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri fonksiyonel tanıyı sorgulatır ve hedefli tetkik ile organik hastalık dışlamasını gerektirir.

• İstemsiz kilo kaybı

• Doğrusal büyümede duraklama / boy hızında yavaşlama

• Gecikmiş puberte

• GİS kanama: hematokezya, melena, gizli kan

• Gece uyandıran ağrı veya ishal

• İnatçı veya safralı kusma

• Kronik şiddetli ishal

• Disfaji / odinofaji

• Umbilikustan uzak, lokalize veya persistan ağrı (özellikle sağ üst/alt kadrın)

• Açıklanamayan ateş

• Perianal hastalık: fistül, fissür, deri lezyonu

• Artrit, aftöz stomatit, cilt bulguları

• IBD, çölyak veya peptik ülser aile öyküsü

• Anemi, hipoalbüminemi, yüksek inflamatuvar belirteç

Temel taş biyopsikososyal eğitim ve etkin güvencedir; hedef ağrının yok edilmesi değil, işlevselliğin (okul devamı, aktivite) yeniden kazanılmasıdır. Diyet-yaşam düzenlemesi ile başlanır, farmakoterapi baskın fenotipe/semtoma göre eklenir ve her müdahale 4 haftalık deneme sonrası değerlendirilir. Düşük FODMAP diyeti diyetisyen eşliğinde ve süreli (eliminasyon + yapılandırılmış reintrodüksiyon) uygulanmalı, büyüme izlenmelidir.

Pediyatrik fonksiyonel karın ağrısında basamaklı ve dozlu tedavi

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Eğitim + güvence (tüm hastalar)	—
Psikolojik tedavi	—
Çözünür lif · Psyllium (ispaghula)	0,2 g/kg/gün (yaklaşık 5–10 g/gün), bölünmüş; bol su ile
Düşük FODMAP diyeti	2–6 hafta eliminasyon → yapılandırılmış reintrodüksiyon
Probiyotik (adjuvan)	Lactobacillus rhamnosus GG 10^9 – 10^{10} CFU/gün, 4 hafta

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Nane yağı (enterik kaplı; ağrı/şişkinlik)	>8 yaş; <45 kg: 187 mg günde 3, ≥45 kg: 187–374 mg g
Hiyosin butilbromür (antispazmodik)	6–12 yaş: 10 mg günde 3; >12 yaş: 10–20 mg günde 4 (
Mebeverin (antispazmodik)	>10 yaş / >30 kg: 135 mg günde 3, öğünden ~20 dk önc
Siproheptadin (ağrı/dispepsi baskın)	2–6 yaş: 2 mg günde 2–3 (maks 12 mg/gün); 7–14 yaş:
Famotidin / PPI (dispepsi örtüşmesi)	Famotidin 0,5 mg/kg/doz günde 2 (maks 40 mg/gün); P
Amitriptilin (dirençli, ağrı baskın)	10 mg gece ile başla; 0,2–0,5 mg/kg gece (maks ~25–50

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Sitalopram (dirençli, anksiyete örtüşmesi)	10 mg/gün ile başla; 10–20 mg/gün (maks ~20 mg/gün)

Yaklaşım: Tek müdahaleyi 4 hafta dene; yanıt yoksa baskın fenotipi ve mekanizmayı yeniden değerlendirip değiştir (dispepside siproheptadin/asit baskılama, IBS'de lif/düşük FODMAP-antispazmodik, ağrı baskında nane yağı/antispazmodik → nöromodülatör). BDT ve hipnoterapi farmakoterapiye eşdeğer veya üstün kanıta sahiptir; erken devreye alın.

Fonksiyonel karın ağrısı kronik-dalgalanan bir seyir gösterir; hedef semptom kontrolü, işlevsellik (okul devamı) ve gereksiz tekrarlayan tetkikin önlenmesidir. Etkin iletişim ve güvence en tutarlı sonucu verir.

İzlem

- Pozitif tanıyı ve biyopsikososyal modeli güvence ile pekiştir; ailenin kaygısını doğrudan ele al ve "gerçek ama tehlikesiz ağrı" mesajını ver
- Her müdahaleyi 4 haftada değerlendir; yanıt varsa sürdür, yoksa mekanizmaya göre değiştir
- İşlevsel hedefe odaklan (okul devamı, aktivite); ağrı skorundan çok günlük işlevi izle
- Büyüme eğrisini ve besin yeterliliğini her vizitte izle; düşük FODMAP'ta reintrodüksiyonu tamamla
- Yeni alarm bulgusunda veya atipik seyirde yeniden değerlendir; aksi halde tetkik tekrarından kaçın

Dirençli olguda

- Baskın fenotipi ve mekanizmayı yeniden gözden geçir; örtüşen dispepsi/IBS/abdominal migreni ayır
- Komorbiditeleri ele al: anksiyete/depresyon, uyku bozukluğu, migren, otonom disfonksiyon
- Nöromodülatör (amitriptilin/sitalopram) ekle; psikolojik tedaviye (BDT, hipnoterapi) yönlendir
- Post-enfeksiyöz başlangıç, diyet tetikleyicileri ve abdominal duvar ağrısını (Carnett) değerlendir
- Okul devamsızlığı ve aile beklentilerini yönet; multidisipliner destek (psikoloji, diyetisyen) kur

Farmakoterapi tek başına değil, diyet, davranışsal tedavi ve sürekli terapötik ilişki içeren biyopsikososyal plan içinde konumlandırılmalıdır; etkin güvence, gereksiz tetkikten kaçınma ve işlevselliğe odaklanma alevlenme-remisyon döngüsünde en kalıcı yararı sağlar.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, Shulman RJ, Staiano A, van Tilburg M. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Thapar N, Benninga MA, Crowell MD, et al. Paediatric functional abdominal pain disorders. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:89.
3. Rexwinkel R, Vlieger AM, Saps M, Tabbers MM, Benninga MA. A therapeutic guide on paediatric irritable bowel syndrome and functional abdominal pain-not otherwise specified. Eur J Pediatr. 2021;180(9):2839-2850.
4. Jones NL, Koletzko S, Goodman K, et al. Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(6):991-1003.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulama koşullarının yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre doğrulanmalıdır.